

Decisions informades

APARTAT 1

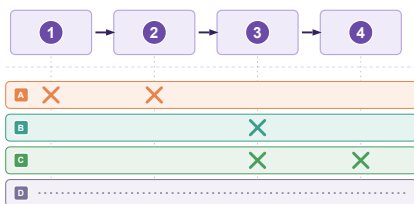
CRÍTIC: com es mira una afirmació que corre

Davant d'una afirmació no cal **creure-se-la ni rebutjar-la de cop**: es mira amb sis caselles. **C**onsigna — quina és **exactament** l'afirmació? · **R**ol — qui ho diu i **què hi guanya?** · **I**dees — quin **mecanisme** proposa? En proposa cap? · **T**est — **es podria comprovar**, i com? · **I**nformació — quines **dades** hi posa? Un cas que algú explica és una **anècdota**, i una anècdota **no és una dada**: sempre n'hi haurà alguna en cada direcció. · **C**onclusions — què en puc dir ara i **què em falta saber?** I una advertència sobre la **IA**: no és una font, és un programa que **redacta**. Pot donar-te una font que **no diu el que ell diu**, o que no existeix. Si te'n dona una, **ves a mirar-la**.

APARTAT 2

La cadena de quatre baules i on talla cada família

Perquè hi hagi un embaràs han de passar **quatre coses seguides**: ① **el cervell dona l'ordre d'ovular** (les hormones de la hipòfisi) → ② **surt l'òvul** de l'ovari → ③ **els gàmetes es troben** a la trompa → ④ **l'embrió s'implanta** a la paret de l'úter. **Si en falla una, no hi ha embaràs**. Per això cada família de mètodes **talla la cadena en un punt diferent**. **Hormonals** (píndola combinada, pegat transdèrmic, implant subcutani): aporten hormones que fan que **no arribi l'ordre d'ovular** → tallen a ①-②. Gairebé tots els mètodes fan **més d'una cosa alhora** —els hormonals també espesseixen el moc del coll de l'úter, que és una segona tanca a ③—, però la figura marca **on talla principalment** cada família, que és el que se't demanarà. **De barrera** (preservatiu extern i intern): impedeixen físicament que el semen entri en contacte amb la vagina → tallen a ③. **DIU de coure**: els ions de coure fan l'ambient **tòxic per als espermatozoides** —això és el principal— i, si tot i així hi ha fecundació, dificulten la implantació → talla a ③ i ④. I el **mètode del calendari** **no talla res**: no fa res al cos, només intenta endevinar quins dies són fèrtils.



Per quina raó només una família atura també els patògens

El preservatiu és l'únic que atura **els fluids**. I és als fluids que hi van els **patògens** — recorda «Defensors del cos»: una **ITS** (infecció de transmissió sexual) és una infecció, i el preservatiu hi fa de **barrera**, exactament igual que la pell. Els mètodes **hormonals** i el **DIU** actuen sobre el cicle o dins de l'úter: eviten l'embaràs, però **no impedeixen que els fluids es trobin**. Fixa-t'hi bé, perquè és l'error més freqüent: la pregunta no és **com de bo és** un mètode contra l'embaràs, és **què atura**. Per això el consell sanitari és la **dobla protecció**: preservatiu **més** un altre mètode. I un matís que cal dir bé: el preservatiu **redueix molt** el risc d'ITS, però **no el deixa a zero** — hi ha infeccions que passen per **contacte de pell** que la funda no cobreix. Dir «protegeix» és correcte; dir «protegeix del tot», no.

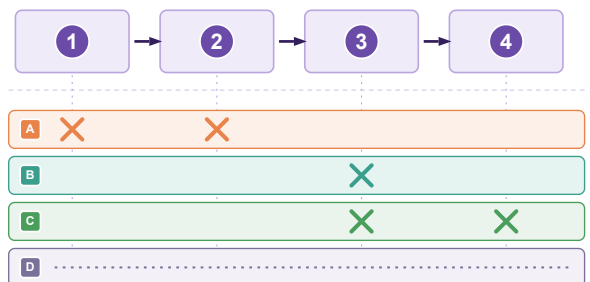
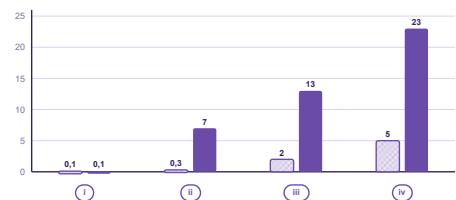
⚠ La confusió més estesa

La píndola de l'endemà: què fa i què no fa

És un mètode **d'emergència**, no del dia a dia. El que fa és **retardar o impedir l'ovulació**: actua a les baules ①-②, com la resta d'hormonals. Per això com abans es pren, **millor funciona**. I una cosa que convé tenir clara perquè es confon molt sovint: **no interromp un embaràs que ja està en marxa** — si la implantació ja s'ha produït, no hi fa res.

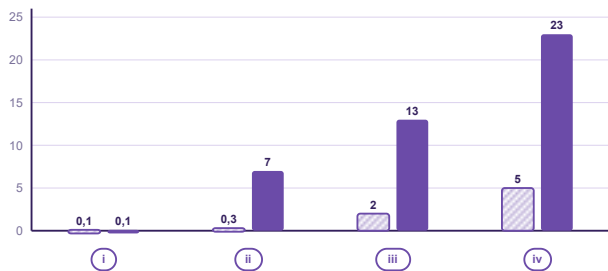
Ús perfecte i ús real: la distància entre les dues barres

Els mètodes es comparen amb una xifra: quantes persones de cada **100** tenen un embaràs no buscant **en un any**. I sempre se'n donen **dues**: la de l'**ús perfecte** (fent-ho sempre bé, sense cap badada) i la de l'**ús real** (com ho fa la gent de veritat). **La segona mai no és millor** —i sovint és molt pitjor—, però no en la mateixa mesura per a tots: n'hi ha que tenen les dues barres iguals, com **més depèn el mètode de fer alguna cosa bé cada vegada** (o cada dia), **més s'allunyen les dues barres**. Un implant, un cap col·locat, no depèn de res; una píndola depèn de cada dia; un preservatiu, de cada vegada. I el **mètode del calendari** depèn de cada cicle **i a més cal encertarlo** — i a la sessió 2 ja vas veure, amb el cicle de la Laia, que el dia d'ovulació **no és fix**.



F1 — La cadena i on talla cada família

A dalt, les quatre baules amb marcadors ①-④. A baix, quatre files amb marcadors [A]-[D] en QUADRAT DE COLOR PLE (sistema diferent del rodó de les baules, perquè no es confonguin) i una X sota cada baula que talla aquella família. La fila [D] no en té cap: aquest buit és el missatge, no un oblit. Cap paraula dins la imatge; les etiquetes són la llegenda de la fitxa.



F2 — Ús perfecte contra ús real

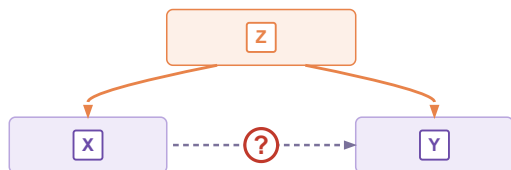
Barres aparellades: embarassos no buscats per cada 100 persones en un any. Les dues barres del mateix mètode són del MATEIX color: el que es mira no és el color sinó l'emplenat — barra buida per dins = ús perfecte, barra plena = ús real. (i) implant · (ii) pílula · (iii) preservatiu · (iv) calendari · (v) cap mètode. Marcadors en NÚMERO ROMÀ dins d'un rètol arrodonit i buit, perquè a la mateixa pàgina F1 ja fa servir els ①-④ (baules) i els [A]-[D] (famílies): tres sistemes, tres significats. Xifres aproximades d'organismes de salut: serveixen per comparar mètodes, no per predir res d'una persona concreta.

APARTAT 3

El nucli epistèmic del dia

El mite, desmuntat

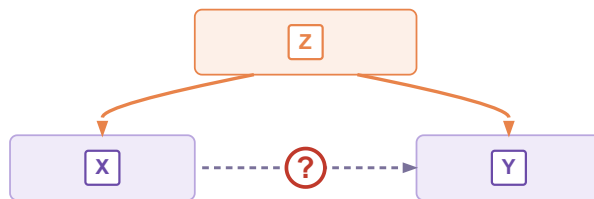
«Els anticonceptius et fan infèrtil per sempre.» Mirem-ho amb el que sabem. **Què diu l'evidència:** quan es deixa un anticonceptiu hormonal, **el cicle es restableix**, i els estudis que han seguit **molta gent durant anys** no troben que la fertilitat quedi tocada a llarg termini. **I per quina raó l'afirmació no s'aguanta?** Per tres coses alhora: (a) no proposa **cap mecanisme** — no diu **què** faria l'hormona per espantllar res; (b) no aporta **cap dada**, només casos que algú explica; i (c) confon **una cosa que passa després** amb **una cosa que passa per culpa de**. Si algú deixa la pílula als 34 anys i triga a tenir un embaràs, la pílula no és l'única cosa que ha canviat: **també ha canviat l'edat**. Això té nom: la **tercera variable** — una cosa que ha canviat alhora i que ningú no havia mirat, i que pot estar causant les altres dues. *(A la fitxa de la versió A hi ha una figura que ho dibuixa; a la resta n'hi ha prou amb aquest exemple.)* I sobre el «la pílula engreixa»: aquí no es discuteix el cos de ningú, es discuteix **fins on arriba l'afirmació**. Els efectes secundaris **existeixen** i són **diferents en cada persona** — per això això es parla amb un professional. El que no té base és el salt de «a algunes persones els passa» a **«això li passa a tothom, sempre»**.



❖ Tancament de la unitat

Com es decideix una cosa sobre el propi cos

No per por i no perquè una cosa estigui de moda. Es miren **tres coses** **alhora**: (1) **què diu l'evidència**; (2) **quina és l'eficàcia real**, no la del paper; i (3) el **context de cada persona**, que és diferent per a cadascú. I qui ho decideix és **la persona, amb un professional sanitari** — no una xarxa social i no una classe de biologia. El que fa la biologia és donar-te el **mecanisme**, perquè puguis **entendre el que et diguin** i preguntar bé. On es pot preguntar de debò: el **CAP** del barri (hi ha consulta jove, gratuïta i confidencial), el programa **Salut i Escola** del centre i **Canal Salut**, el web sanitari públic.



F3 — La tercera variable

Rètols en LLETRA dins d'un quadrat buit, que és el sistema que es fa servir per parlar de causes: X deixar l'anticonceptiu · Y trigar a tenir un embaràs · Z l'edat, que ha canviat alhora. La fletxa de punts entre X i Y, amb un ? vermell al mig, és la conclusió que la gent dona per bona i que no està demostrada; les dues fletxes taronges són l'explicació alternativa (Z causa X i Y alhora). Només és a la fitxa de la versió A: a les altres dues versions la idea es treballa amb text, sense la figura.